WIRKUNGSÖKONOMIE

FÜR MENSCH, PLANET UND DEMOKRATIE

Gesundheit & Pflege - umfangreiche Einzeldossiers

Von der Krankheitsfinanzierung zur Wirkungsgesundheit

Dokumenttyp	Einzeldossier-Set
Autorin	Natalie Weber
Referenz	Wirkungsökonomie
Version	v0.2
Stand	24. Mai 2026
Status	Arbeitsfassung / Diskussionsfassung

Leitsatz

Gesundheit wird nicht erst dann finanziert, wenn sie verloren ist. Gesundheit wird als Zustand erzeugt, geschützt, gemessen und gerecht zugänglich gemacht.

Dossier-Methodik

Einzeldossiers übersetzen Detailkonzepte in konkrete Beispiele, Datenquellen, Berechnungswege, Toollogik und politische Umsetzung. Sie dienen nicht der medizinischen Diagnose, sondern der Planung und Bewertung von Systemwirkungen.

Gesundheit als gesellschaftliches Wirkungsfeld

Gesundheit entsteht in Lebensbedingungen, Versorgung, Arbeit, Wohnen, Ernährung, Bildung, Kultur, Umwelt, digitaler Öffentlichkeit und Vertrauen. Dieses Detailkonzept begründet Gesundheit als gesamtgesellschaftliche Wirkungsinfrastruktur.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

- Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.
- Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.
- Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.
- Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- psychosoziale Risiken
- Lokale Emissionen NOx/PM/SOx
- Gesunde Gebäude und Innenraumluft
- Lärm-Exposition
- Stadtgrün/Naturzugang
- Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart	Beispiel	Schutzanforderung
Strukturdaten	Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	keine personenbezogene Sanktionierung

Sozialraumdaten	Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	kommunale Transparenz und Kontext
Versorgungsdaten	Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung
Qualitative Daten	Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Wirkungsnutzen = vermiedene Behandlungskosten + vermiedene Pflegeeskalation + reduzierte Arbeitsausfälle + Angehörigenentlastung + Resilienzgewinn + Teilhabewirkung - Programmkosten - Nebenwirkungen. Alle Annahmen werden als Quelle, Schätzung oder Modellwert gekennzeichnet.

Prävention, Gesundheitskassen und Wirkungshaushalt

Prävention wird zur ersten Wirkleistung. Vermiedene Schäden, längere Autonomie, weniger Pflegebedarf und geringere Krisenlast werden sichtbar und haushaltsfähig.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

- Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.
- Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.
- Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.
- Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- psychosoziale Risiken
- Lokale Emissionen NOx/PM/SOx
- Gesunde Gebäude und Innenraumluft
- Lärm-Exposition
- Stadtgrün/Naturzugang
- Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart	Beispiel	Schutzanforderung
Strukturdaten	Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	keine personenbezogene Sanktionierung
Sozialraumdaten	Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	kommunale Transparenz und Kontext
Versorgungsdaten	Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung
Qualitative Daten	Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Wirkungsnutzen = vermiedene Behandlungskosten + vermiedene Pflegeeskalation + reduzierte Arbeitsausfälle + Angehörigenentlastung + Resilienzgewinn + Teilhabewirkung - Programmkosten - Nebenwirkungen. Alle Annahmen werden als Quelle, Schätzung oder Modellwert gekennzeichnet.

Versorgungsräume, Kliniken und Gesundheitsnetzwerke

Versorgung wird von Sektorengrenzen auf integrierte Wirkungsräume umgestellt: ambulant, stationär, mobil, digital, psychisch, pflegerisch und kommunal.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

- Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.
- Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.
- Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.
- Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- psychosoziale Risiken
- Lokale Emissionen NOx/PM/SOx
- Gesunde Gebäude und Innenraumluft
- Lärm-Exposition
- Stadtgrün/Naturzugang

- Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart	Beispiel	Schutzanforderung
Strukturdaten	Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	keine personenbezogene Sanktionierung
Sozialraumdaten	Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	kommunale Transparenz und Kontext
Versorgungsdaten	Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung
Qualitative Daten	Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Wirkungsnutzen = vermiedene Behandlungskosten + vermiedene Pflegeeskalation + reduzierte Arbeitsausfälle + Angehörigenentlastung + Resilienzgewinn + Teilhabewirkung - Programmkosten - Nebenwirkungen. Alle Annahmen werden als Quelle, Schätzung oder Modellwert gekennzeichnet.

Pflege als Wirkleistung und Pflegeökosystem

Pflege ist Beziehungs-, Würde- und Stabilitätsarbeit. Sie erhält Autonomie, entlastet Familien, verhindert Folgeschäden und braucht eine eigene Wirkungsarchitektur.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

- Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.
- Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.
- Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.
- Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- psychosoziale Risiken
- Lokale Emissionen NOx/PM/SOx
- Gesunde Gebäude und Innenraumluft
- Lärm-Exposition
- Stadtgrün/Naturzugang
- Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart	Beispiel	Schutzanforderung
Strukturdaten	Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	keine personenbezogene Sanktionierung
Sozialraumdaten	Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	kommunale Transparenz und Kontext
Versorgungsdaten	Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung
Qualitative Daten	Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Wirkungsnutzen = vermiedene Behandlungskosten + vermiedene Pflegeeskalation + reduzierte Arbeitsausfälle + Angehörigenentlastung + Resilienzgewinn + Teilhabewirkung - Programmkosten - Nebenwirkungen. Alle Annahmen werden als Quelle, Schätzung oder Modellwert gekennzeichnet.

Psychische Gesundheit und soziale Stabilität

Psychische Gesundheit wird als Systembedingung von Demokratie, Arbeit, Bildung und sozialem Zusammenhalt gelesen. Einsamkeit, digitale Gewalt, Stress und Überforderung werden als Wirkungsrisiken sichtbar.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

- Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.
- Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.
- Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.
- Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

- Arbeits- und Gesundheitsschutz

- psychosoziale Risiken
- Lokale Emissionen NOx/PM/SOx
- Gesunde Gebäude und Innenraumluft
- Lärm-Exposition
- Stadtgrün/Naturzugang
- Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart	Beispiel	Schutzanforderung
Strukturdaten	Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	keine personenbezogene Sanktionierung
Sozialraumdaten	Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	kommunale Transparenz und Kontext
Versorgungsdaten	Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung
Qualitative Daten	Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Wirkungsnutzen = vermiedene Behandlungskosten + vermiedene Pflegeeskalation + reduzierte Arbeitsausfälle + Angehörigenentlastung + Resilienzgewinn + Teilhabewirkung - Programmkosten - Nebenwirkungen. Alle Annahmen werden als Quelle, Schätzung oder Modellwert gekennzeichnet.

Gesundheitsgerechtigkeit, Inklusion und Migration

Gesundheitsgerechtigkeit heißt, vermeidbare und systematisch erzeugte Unterschiede nicht als privates Schicksal zu behandeln. Migration ist zugleich Versorgungsfaktor, Fachkräftefrage und Teilhabefrage.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

- Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.
- Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.
- Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.
- Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- psychosoziale Risiken
- Lokale Emissionen NOx/PM/SOx
- Gesunde Gebäude und Innenraumluft
- Lärm-Exposition
- Stadtgrün/Naturzugang
- Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart	Beispiel	Schutzanforderung
Strukturdaten	Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	keine personenbezogene Sanktionierung
Sozialraumdaten	Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	kommunale Transparenz und Kontext
Versorgungsdaten	Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung
Qualitative Daten	Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Wirkungsnutzen = vermiedene Behandlungskosten + vermiedene Pflegeeskalation + reduzierte Arbeitsausfälle + Angehörigenentlastung + Resilienzgewinn + Teilhabewirkung - Programmkosten - Nebenwirkungen. Alle Annahmen werden als Quelle, Schätzung oder Modellwert gekennzeichnet.

One Health, Klima, Umwelt und Ernährung

Gesundheit ist planetar verbunden: Hitze, Luft, Wasser, Boden, Biodiversität, Ernährung, Chemikalien, Lärm und Naturzugang sind Gesundheitsfaktoren.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

- Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.
- Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.
- Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.

- Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- psychosoziale Risiken
- Lokale Emissionen NOx/PM/SOx
- Gesunde Gebäude und Innenraumluft
- Lärm-Exposition
- Stadtgrün/Naturzugang
- Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart	Beispiel	Schutzanforderung
Strukturdaten	Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	keine personenbezogene Sanktionierung
Sozialraumdaten	Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	kommunale Transparenz und Kontext
Versorgungsdaten	Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung
Qualitative Daten	Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Wirkungsnutzen = vermiedene Behandlungskosten + vermiedene Pflegeeskalation + reduzierte Arbeitsausfälle + Angehörigenentlastung + Resilienzgewinn + Teilhabewirkung - Programmkosten - Nebenwirkungen. Alle Annahmen werden als Quelle, Schätzung oder Modellwert gekennzeichnet.

Arbeitswelt, Unternehmen und Gesundheitswirkung

Arbeit ist Gesundheitsraum. Führung, Arbeitszeit, KI-Druck, Schichtsysteme, Sicherheit, Anerkennung und Beteiligung wirken auf Körper und Psyche.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

- Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.
- Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.
- Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.
- Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- psychosoziale Risiken
- Lokale Emissionen NOx/PM/SOx
- Gesunde Gebäude und Innenraumluft
- Lärm-Exposition
- Stadtgrün/Naturzugang
- Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart	Beispiel	Schutzanforderung
Strukturdaten	Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	keine personenbezogene Sanktionierung
Sozialraumdaten	Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	kommunale Transparenz und Kontext
Versorgungsdaten	Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung
Qualitative Daten	Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Wirkungsnutzen = vermiedene Behandlungskosten + vermiedene Pflegeeskalation + reduzierte Arbeitsausfälle + Angehörigenentlastung + Resilienzgewinn + Teilhabewirkung - Programmkosten - Nebenwirkungen. Alle Annahmen werden als Quelle, Schätzung oder Modellwert gekennzeichnet.

Gesundheitsdaten, KI und Bürgerkontrolle

Daten können Frühwarnung, Versorgung und Prävention verbessern, müssen aber gemeinwohlgebunden, transparent, sicher und unter Bürgerkontrolle bleiben.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

- Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.
- Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.
- Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.
- Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- psychosoziale Risiken
- Lokale Emissionen NOx/PM/SOx
- Gesunde Gebäude und Innenraumluft
- Lärm-Exposition
- Stadtgrün/Naturzugang
- Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart	Beispiel	Schutzanforderung
Strukturdaten	Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	keine personenbezogene Sanktionierung
Sozialraumdaten	Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	kommunale Transparenz und Kontext
Versorgungsdaten	Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung
Qualitative Daten	Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Wirkungsnutzen = vermiedene Behandlungskosten + vermiedene Pflegeeskalation + reduzierte Arbeitsausfälle + Angehörigenentlastung + Resilienzgewinn + Teilhabewirkung - Programmkosten - Nebenwirkungen. Alle Annahmen werden als Quelle, Schätzung oder Modellwert gekennzeichnet.

Finanzierung, Wirkungsfonds und Gesundheitskassen

Finanzierung wird von Reparatur auf Wirkung verschoben: Präventionsfonds, Gesundheitskassen, Pflegeentlastungsfonds und Wirkungshaushalte machen verhinderte Schäden sichtbar.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

- Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.
- Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.
- Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.
- Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- psychosoziale Risiken
- Lokale Emissionen NOx/PM/SOx
- Gesunde Gebäude und Innenraumluft
- Lärm-Exposition
- Stadtgrün/Naturzugang
- Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart	Beispiel	Schutzanforderung
Strukturdaten	Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	keine personenbezogene Sanktionierung

Sozialraumdaten	Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	kommunale Transparenz und Kontext
Versorgungsdaten	Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung
Qualitative Daten	Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Wirkungsnutzen = vermiedene Behandlungskosten + vermiedene Pflegeeskalation + reduzierte Arbeitsausfälle + Angehörigenentlastung + Resilienzgewinn + Teilhabewirkung - Programmkosten - Nebenwirkungen. Alle Annahmen werden als Quelle, Schätzung oder Modellwert gekennzeichnet.

Versorgung, Kliniken und Gesundheitsnetzwerke

Kliniken bleiben wichtig, werden aber nicht allein nach Fallzahlen gesteuert. Vorhaltung, Qualität, Koordination, Übergänge und Prävention werden Teil der Wirkungslogik.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

- Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.
- Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.
- Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.
- Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- psychosoziale Risiken
- Lokale Emissionen NOx/PM/SOx
- Gesunde Gebäude und Innenraumluft
- Lärm-Exposition
- Stadtgrün/Naturzugang
- Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart	Beispiel	Schutzanforderung
Strukturdaten	Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	keine personenbezogene Sanktionierung
Sozialraumdaten	Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	kommunale Transparenz und Kontext
Versorgungsdaten	Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung
Qualitative Daten	Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Wirkungsnutzen = vermiedene Behandlungskosten + vermiedene Pflegeeskalation + reduzierte Arbeitsausfälle + Angehörigenentlastung + Resilienzgewinn + Teilhabewirkung - Programmkosten - Nebenwirkungen. Alle Annahmen werden als Quelle, Schätzung oder Modellwert gekennzeichnet.

Governance, Wirkungsrat und politische Anschlussfähigkeit

Gesundheitspolitik bleibt demokratischer Aushandlungsraum. Die WÖk definiert Rahmen, Indikatoren, Schutzgrenzen und Korrekturverfahren, aber keinen Parteibeschluss.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

- Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.
- Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.
- Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.
- Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- psychosoziale Risiken
- Lokale Emissionen NOx/PM/SOx
- Gesunde Gebäude und Innenraumluft
- Lärm-Exposition
- Stadtgrün/Naturzugang

- Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart	Beispiel	Schutzanforderung
Strukturdaten	Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	keine personenbezogene Sanktionierung
Sozialraumdaten	Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	kommunale Transparenz und Kontext
Versorgungsdaten	Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung
Qualitative Daten	Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Wirkungsnutzen = vermiedene Behandlungskosten + vermiedene Pflegeeskalation + reduzierte Arbeitsausfälle + Angehörigenentlastung + Resilienzgewinn + Teilhabewirkung - Programmkosten - Nebenwirkungen. Alle Annahmen werden als Quelle, Schätzung oder Modellwert gekennzeichnet.

Quellen und Anschlussdokumente

- Natalie Weber: Die neue Ordnung des Wohlstands, Arbeitsfassung 2026, Kapitel 68 Gesundheit und Kapitel 69 Pflege.
- Natalie Weber: Systemmodell der Wirkungsökonomie, Spalte 7 Gesundheit, Pflege & Leben.
- Natalie Weber: Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie v1.0.
- WHO Constitution und WHO Social Determinants of Health, 2025.

- OECD Health at a Glance 2025 - Germany.
- Destatis: Gesundheitsausgaben und Pflegebedürftigkeit.
- EU-Kommission: European Health Data Space Regulation.
- BMG: Krankenhausreform und Pflegekompetenzgesetz.